Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
(ГБУЗ МО «МОКПТД»)

ПРИКАЗ

«28» июня 2022 №217/22

Об алгоритме контроля за оформлением и ведением медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014г. № 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению", Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019г. № 127н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза и признании утратившими силу пунктов 16 - 17 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 932н", Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2021 г. N 1051н "Об утверждении Порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, формы информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и формы отказа от медицинского вмешательства", Распоряжения Министерства здравоохранения Московской области от 19.07.2021 № 144-Р «Об утверждении форм информированных согласий на обработку и передачу персональных данных, а также на обработку и передачу специальных категорий персональных данных», Распоряжения Минздрава МО от 01.09.2017 N 245-Р "О совершенствовании мероприятий по выявлению туберкулезной инфекции у детей в Московской области", Распоряжения Министерства здравоохранения Московской области от 29 марта 2018 г. N 49-Р "О применении кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении в медицинских организациях Московской области при обследовании групп риска по

туберкулезу", Приказа Минздрава РФ от 21 марта 2003г. №109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации", Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить алгоритм контроля за оформлением и ведением медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (Приложение).
2. Заведующим филиалами и иными обособленными структурными подразделениями ГБУЗ МО «МОКПТД» организовать работу по контролю за оформлением и ведением медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, согласно прилагаемого алгоритма.
3. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить заместителя главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях Шешелякину Н.Н.

Главный врач С.В. Смердин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «28» июля 2022 г. №217/22

Алгоритм контроля. Оценка качества ведения медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях.			
	Порядок оценки	**Да**	**Нет**
1.0.	**Оформление титульного листа формы 025/У, паспортные данные.**		
1.1.	*Титульный лист соответствует учетной форме N 025/У приказа №834р от 15.12.2014. Указан код формы в грифе (Шаблон из ЕМИАС).*		
1.2.	*Проверить наличие следующих данных:*		
1.3.	*Обозначение юридического лица (адрес и название медицинской организации) верхний левый угол формы*		
1.4.	*ФИО, дата рождения*		
1.5.	*п.5 место регистрации и место проживания*		
1.6.	*п.7; п. 8; п. 11 номера, серии полиса, СНИЛС; документов удостоверяющих личность*		
1.7.	*№ амбулаторной карты, № участка; № ФРБТ*		
1.8.	*п.6 телефон пациента и (или) телефон доверенного лица*		
1.9.	*№ амбулаторной карты, № участка; № ФРБТ*		
1.10.	*п.6 телефон пациента и (или) телефон доверенного лица*		
1.11.	***Копии паспорта, СНИЛС и др. документов, только с письменного согласия пациента!***		
2.0.	**Диагноз диспансерного наблюдения, информированные согласия, извещения о взятии на противотуберкулезный учет.**		
2.1.	*Наличие диагноза (заболевание по поводу которого проводится диспансерное наблюдение) п.12 (ЕМИАС)*		
2.2.	*Проверить внесение данных об аллергической реакции (перечень препаратов с описанием аллергических реакций и нежелательных реакций (п 23. на оборотной стороне формы 025/у)*		
2.3.	*Корешок извещения о постановке на диспансерный учёт (Пр. №127н - Диспансерное наблюдение…")*		
2.4.	*Проверить наличие и качество заполнения согласия на медицинское вмешательство учетной формы приложения № 2 приказа МЗ РФ от 12.11.2021 № 1051н (С указанием, кому пациент доверяет информацию ~~о себе~~ о состоянии своего здоровья)*		
2.5.	*Проверить наличие соответствия согласия на обработку персональных данных учетной форме приказа ГБУЗ МО «МОКПТД» от 10.03.2022 № 76/22-1 "Об утверждении форм информированных добровольных согласий (Приложение 1) или формы, утвержденной Министерством здравоохранения Московской области от 19.07.2021 № 144 (в ЕМИАС)*		

2.6.	*Проверить наличие информированного добровольного согласия на проведение кожных проб (Диаскинтест) для диагностики туберкулеза или отказ от них у детей (распоряжение Минздрава Московской области от 01.09.2017 № 245-Р)*		
2.7.	*Проверить наличие согласия на проведение диаскинтеста у взрослых (форма, утвержденная Распоряжением МЗ МО от 29.03.2018 № 49-р, Приложение № 2).*		
2.8.	*Проверить разборчивость печатного текста в бланках согласий, отсутствие обрезки текста (сохранения полей) - возможна потеря качества при многократных копированиях бланков*		
3.0.	**Качество оформления типовых (типографских) шаблонов медицинской карты** пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях		
	Проверить наличие шаблонов, полноту записей в типовых шаблонах:		
3.1.	*"Медицинская карта больного туберкулезом" по форме N 081/У приказ №1030, обратить внимание - указана ли, инвалидность, эпидемиологический анамнез и т.д.*		
3.2.	*Шаблон "Результаты иммунодиагностики"*		
3.3.	*Лист уточненных диагнозов, наличие подписи заведующего отделением, соответствие даты установки диагноза на ВК, взятии на ПТУ.*		
3.4.	*Диагноз туберкулеза сформулирован правильно, соответствует классификации - указана форма процесса, локализация, фаза, наличие бактериовыделения, лекарственная устойчивость, осложнения, сопутствующая патология. Сокращения не допускаются.*		
3.5.	*"Бактериограмма". Вносятся все имеющиеся результаты анализа мокроты, в том числе из стационара, всеми методами.*		
3.6.	*"Клинико-экспертный анамнез" заполняется в том числе и в случае если пациент не работает*		
3.7.	*"Лист учета дней нетрудоспособности", указано Ф.И.О. и дата оформления первичного листка нетрудоспособности*		
3.8.	*"Лист учета дозовых нагрузок". Указать дозы лучевых нагрузок при исследовании в других организациях (дозы указаны в протоколах результатов исследований).*		
3.9.	*"Эпикриз на ВК, с протоколом (решением) для взятия на противотуберкулезный учет" обратить внимание на наличие 3х подписей врачей, председателя и членов комиссии. Диагноз (полный), с ГДН, наличием или отсутствием МБТ, планом наблюдения и лечения. (ЕМИАС)*		
3.9.1.	*"Этапный эпикриз за прошедший год"-наличие подписи заведующего отделения. План наблюдения на следующий год.*		
4.0	**"Обследование бытового очага туберкулезной инфекции"**		

4.1.	*Выход в очаг осуществлен не позднее 3х рабочих дней после постановки на ПТУ (амб карта, эпидкарта, карта уч. м.с.)*		
4.2.	*Описание материально - бытовых условий, соблюдение гигиенических норм и правил в семье. Перечислены семейные контакты, запись о наличии или отсутствии детей в очаге их возраст;*		
4.3.	*Описаны территориальный, производственный очаг и сведения об обследовании контактных, круг общения;*		
4.4.	*Даты передачи сведений о территориальном очаге во взрослую и детскую поликлинику*		
5.0.	**Оформление первичного посещения пациента**		
5.1.	*Наличие направления от терапевта или другого специалиста.*		
5.2.	*Наличие записи кем направлен пациент или как получена информация о пациенте (самообращение, письмо-уведомление, Форма №089\У, и т.п.)*		
5.3.	*Наличие жалоб и объективного исследования отражающих синдром интоксикации или поражения того или иного органа, указаны АД, ЧСС, ЧДД, масса тела, рост. При необходимости - сатурация.*		
5.4.	*Сбор и оформление развернутого эпидемиологического анамнеза.*		
5.5.	*Был ли туберкулез в анамнезе, если был, указан клинический диагноз, данные ТЛЧ, режим лечения, сроки лечения, методы лечения. Дату снятия с ПТУ.*		
5.6.	*Наличие информации о возможном контакте с больными туберкулезом (семейный, квартирный, производственный, профессиональный, случайный), его давность и длительность. Отсутствие контакта.*		
5.7.	*Наличие информации был ли ранее обследован в противотуберкулезном диспансере, цели консультации фтизиатра, результаты обследования, проводились ли химиопрофилактика*		
5.8.	*Наследственность: были ли в семье больные туберкулезом, бронхолегочной патологией, онкопатологией легких, в каком возрасте болели; какие другие заболевания у близких родственников.*		
5.9.	*Наличие у пациента ХНЗЛ или длительного кашля. Контакт с длительно кашляющими.*		
5.9.1.	*Пребывание в местах лишения свободы(МЛС) (годы). Когда освободился. Принимал химиопрофилактическое лечение в МЛС.*		
5.9.2.	*Принадлежность к группам риска*		
5.9.3.	*Информация о перенесенных инфекционных заболеваниях, переливание крови и кровезамещающих жидкостей. Пребывание за пределами региона, за рубежом в последние 6 месяцев.*		
5.9.4.	*Место работы и условия труда, принадлежность к декретированным контингентам, отметка о наличии другого место работы.*		
5.9.5.	*Материально–бытовые условия.*		

5.9.6.	*Дата и обстоятельства выявления изменений*		
5.9.7.	*Дата предыдущей флюорография, результат исследования*		
5.9.8.	*Анамнез по COVID-19 включая сведения о вакцинации, был ли привлечен к диспансеризации после перенесенного COVID-19. Указать вредные привычки*		
6.0.	**Оформление документации при постановке на учет**		
6.1.	*Проверяется срок установки диагноза не более 14 дней*		
6.2.	*Эпикриз с заключением ВК о постановке на учёт соответствует форме приложения №2 приказа ГБУЗМО «МОКПТД» №18/22 от 18.01.2022 или из ЕМИАС.*		
6.3.	*Обоснование диагноза, подробное и последовательное, основывается на данных анамнеза, жалобах, результатах объективного обследования, результатах лабораторных, рентгенологических, инструментальных и других исследованиях;*		
6.4.	*Диагноз в решении ВК оформлен с указанием формы процесса, локализации, фазы, наличия бактериовыделения, лекарственной устойчивости, осложнений, сопутствующей патологии. Сокращения не допускаются. Указана группа ДН, режим ХТ;*		
6.5.	*В протоколе ВК отражена схема лечения с указанием доз в случае амбулаторного лечения;*		
6.6.	*План ведения;*		
6.7.	*Дата ВК о постановке на учёт совпадает с датой подачи извещений и диагнозом в листе уточненных диагнозов*		
6.8.	*В случае выявления бактериовыделения после постановки на учёт имеется протокол ВК с решением о постановке на бациллярный учёт, проверяется факт подачи повторно ф 0.58/у о наличии бактериовыделения, внесены изменения в выделенную графу журнала № 60. Внесена новая запись в лист уточненных диагнозов*		
6.9.	*Проверяется наличие ежемесячных записей, о пациенте продолжающим лечение в стационаре и краткий план ведения.*		
7.0.	**Оформление этапного эпикриза после выписки из стационара**		
7.1.	*дата госпитализации; дата выписки;*		
7.2.	*диагноз при выписке из стационара;*		
7.3.	*дата начала ИФ, по какому режиму, количество полученных доз, перечень ПТП, количество полученных доз;*		
7.4.	*в случае внесения изменений в схему лечения на стационарном этапе указаны причины замены препаратов. В случае непереносимости лекарств информация вынесена на оборотную сторону формы 025/У п.19 - данные о лекарственной непереносимости*		

7.5.	*отражена динамика заболевания в период стационарного лечения (общее состояние, рентген динамика, результаты исследования мокроты*		
7.6.	*указана дата и результат консультации хирурга*		
7.7.	*отметить отклонение от норм в результатах инструментальных и лабораторных исследований в стационаре*		
7.8.	*дата начала ФП, количество полученных доз, режим, перечень ПТП, № ВК стационара перевода на ФП, количество полученных доз*		
7.9.	*Наличие записи о причине выписки из стационара. Диагноз оформлен с указанием основного заболевания, сопутствующего и осложнений отражены рекомендации стационара при выписке. В наличии план ведения с учетом результата консультации хирурга.*		
7.9.1.	*Наличие протокола ВК после выписки из стационара для всех РХТ (1-V) с целью подтверждения и возможности выдачи назначенных ранее в схеме лекарственных средств .*		
8.0.	**Ведение дневниковых записей наблюдения за амбулаторным лечением (1 раз в 7 дней; чаще при необходимости)**		
8.1.	*Наличие жалоб (детализация)*		
8.2.	*В дневниковых записях должны быть отражены результаты предыдущих лабораторных и инструментальных исследований. Их интерпретация в случаях отклонения от нормы.*		
8.3.	*Полнота объективного осмотра в том числе с указанием АД, ЧСС, ЧДД и сатурацией при распространенном процессе*		
8.4.	*Наличие развернутого диагноза-соответствует классификации-указана форма процесса, локализация, фаза, наличие бактериовыделения, лекарственная устойчивость, сокращения не допускаются. Осложнения, сопутствующий диагноз.*		
8.5.	*Объемы назначений лабораторных и инструментальных методов исследования, их кратность должна сосответствовать клиническим рекомендациям.*		
8.6.	*Проверяется кратность направления пациентов к узким специалистом в соответствии с клиническими рекомендациями и в зависимости от сопутствующей патологии.*		
8.7.	*Оценивается своевременность представления на ВК после завершения текущего этапа лечения*		
8.8.	*Назначение лекарственных средств с учетом способа введения, кратности и времени приема, связь с приемом пищи, указать количесво выданных препаратов "Изониазид 300мг. №20 по 2 таблетки перорально утром один раз в день, через час после завтрака (в 9.00)".*		
8.9.	*Должна быть указана дата следующей явки*		
8.9.1.	*Подпись и расшифровка подписи*		
9.0	**Наличие протоколов ВК (в медицинских записях медицинской карты** пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях**, согласно дате проведения) в следующих случаях:**		
9.1.	*Постановка больного на диспансерный учет, снятие больного с диспансерного наблюдения*		

9.2.	*Перевод в другую группу диспансерного наблюдения*		
9.3.	*После окончания интенсивной фазы лечения, перевода на фазу продолжения.*		
9.4.	*При необходимости продлить фазу лечения свыше установленного решением предыдущей ВК срока*		
9.5.	*При внесении каких либо изменений в схему лечения, смены режима химиотерапии.*		
9.6.	*Появления полости распада или бактериовыделения, внесение изменения в листе уточнения диагнозов.*		
9.7.	*После выписки из стационара пациента, получающего лечение по 1-2-3-4-5 РХТ, дорогостоящие противотуберкулезные препараты, требующие количественного списания.*		
9.8.	*При назначении химиопрофилактического лечения при контакте с больным туберкулезом или превентивного лечения с ЛТИ.*		
9.9.	*При направлении на МСЭ. Оформление формы 088/у (при первичном направлении на МСЭ) или выдача заполненной формы 0/88/у (во всех случаях направления на МСЭ)*		
9.10.	*Допуск к труду или к учебе; разрешение нахождения в детском коллективе. Выдача, продление листка нетрудоспособности свыше 15 дней.*		
9.11.	*Разбор жалоб. Разбор случаев смерти.*		